Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Erechim

Rua Clementina Rossi, 129 - Bairro: Bela Vista - CEP: 99704900 - Fone: (54)30469880 - Email: frerechim2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5019526-95.2022.8.21.0013/RS

AUTOR: MARIA LEIDIANA MENDES DE OLIVEIRA

RÉU: UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

Vistos.

Relatório

MARIA LEIDIANA MENDES DE OLIVEIRA, devidamente qualificada, ajuizou **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA** em face da **UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**, alegando, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde da requerida, bem como que é portadora de obesidade por excesso de calorias (CID 10 E66). Afirmou que, para assegurar o tratamento médico indicado e adequado a sua situação, necessita receber o medicamento SAXENDA 6 mg/ml, de forma contínua e por tempo indeterminado, como terapia complementar. Alegou que a requerida se nega a fornecer referido medicamento, sob a alegação de ausência de cobertura pelo plano de saúde. Requereu, em sede de tutela de urgência, seja a ré compelida ao fornecimento do medicamento, pois imprescindível para seu tratamento. Rogou pelo benefício da gratuidade da justiça. Ao final, requereu o julgamento de procedência do pedido, com o fornecimento do medicamento necessário a seu tratamento. Juntou documentos (Evento 1, INIC1).

Recebida inicial, foi deferido o pedido liminar (Evento 8, DESPADEC1) e determinada a citação.

Irresignada, a parte requerida interpôs agravo de instrumento (Evento 15), ao qual foi dado provimento, revogando-se a liminar concedida (Evento 33, RELVOTO1).

A parte ré apresentou contestação (evento 23, CONT1), informando que o medicamento pleiteado se trata de uma medicação domiciliar, receitado por seu nutrólogo, não havendo qualquer elemento que comprove o risco de morte ou sequer outra condição que respalde a concessão de medida liminar. Referiu que há a perpetuação do mito de que os planos de saúde devem custear de forma indiscriminada tudo o que for receitado aos seus usuários, no entanto, os Tribunais Superiores têm entendido que não se alarga ao dever de garantir o acesso universal de medicamentos pelas operadoras dos planos de saúde. Pugnou pelo julgamento de improcedência dos pedidos formulados pela autora.

Houve réplica à contestação (Evento 38, RÉPLICA1).

Intimadas as partes para declinar quanto à necessidade de produção de outras provas (Evento 39, ATOORD1), a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (evento 44, PET1). Já a demandada requereu a remessa do feito ao NATJUS para averiguar a pertinência técnica do pedido (evento 46, PET1), o que restou indeferido pelo juízo no evento 50, DESPADEC1.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a decidir.

Do julgamento antecipado da lide

Observo, que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, uma vez que a matéria é eminentemente de direito e as provas necessárias ao deslinde da controvérsia já foram devidamente carreadas aos autos.

Preliminares

Não há preliminares a serem enfrentadas.

Mérito

No caso, a existência de relação contratual entre as partes, além de incontroversa, está demonstrada pelos documentos anexados aos autos.

Embora o laudo médico anexado pela parte autora descreva, pormenorizadamente, a necessidade de utilização do medicamento SAXENDA 6MG/ML ao seu tratamento, trata-se de medicamentos de uso domiciliar.

Acerca dos medicamentos e insumos de uso domiciliar, a Lei n.º 9.656/98 incluiu dentre as coberturas obrigatórias apenas aqueles destinados a tratamento antineoplásico oral (e correlacionados), à medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim, *in verbis:*

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;

Cabe salientar que o caso não se enquadra nas exceções previstas no artigo 12 da Lei n.º 9.656/98, que assim dispõe:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

II - quando incluir internação hospitalar:

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

Ademais, assim dispôs a Agência Nacional de Saúde Suplementar na Resolução Normativa n.º 465 de 2021:

Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.

Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;

De se ressaltar que a orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do STJ que tratam da matéria (RESP n.º 1.692.938 - 3ª Turma e n.º 1.883.654 - 4ª Turma) é no sentido de que os planos de saúde não estão obrigados ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar, como previsto no artigo 10 da Lei n.º 9656/98, exceto os relativos ao tratamento de câncer, que são de fornecimento obrigatório em razão de expressa disposição legal, não sendo essa a hipótese dos autos.

Conclui-se, portanto, que o plano de saúde demandado não está obrigado a fornecer o medicamento postulado.

Esse é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, conforme ementas que seguem:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA. DEVER DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. **TOFACITINIBE.** TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES. DECISÃO REFORMADA. - Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, deverá ser revogada a tutela de urgência anteriormente deferida à parte agravada, pela **ausência** dos requisitos supra. - **O fármaco Tofacitinibe 5mg é de uso domiciliar, e portanto não é, a princípio, de fornecimento obrigatório pelos planos de saúde. Ademais, se constata a existência de diversas notas técnicas na plataforma e-NatJus com conclusão desfavorável ao fornecimento da medicação.** - Recurso provido para revogar a tutela de urgência anteriormente deferida. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 52828710820238217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 23-11-2023) - grifei.*

*APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. **PLANO** DE **SAÚDE**. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE ALOPÉCIA AREATA. **MEDICAMENTO TOFACITINIBE. USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. NEGATIVA DE COBERTURA QUE NÃO SE MOSTRA ABUSIVA.** 1) Ausente comando, pelo Superior Tribunal de Justiça, que imponha o sobrestamento dos processos que envolvam a discussão versada nos EREsp1.886.929 e EREsp 1.889.704, a preliminar deve ser desacolhida. 2) Tratando-se de contrato regulamentado, devem ser observadas as coberturas mínimas definidas na Resolução Normativa nº 428/2017, atual RN 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS), que apresenta Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, a qual não pode prever aquelas excetuadas no artigo 10 da Lei nº 9.656/98 e, também, não pode excluir ou mitigar as hipóteses do artigo 12 do mesmo diploma legal. 3) É lícito que se excetue o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar - administração em ambiente externo ao de unidade de saúde (não abrangido o home care) -, salvo os antineoplásicos, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, bem como os serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente (Arts. 10, incs. V e VI e 12, da Lei nº 9.656/98). 4) A vedação constante no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998, voltada à operadora de plano de saúde, não obsta que, na contratação, atendidos os requisitos regulatórios, as partes incluam dentre as coberturas obrigatórias os medicamentos de uso domiciliar, tendo em vista o princípio da autonomia da vontade, relativo à liberdade contratual. Ademais, é possível a contratação acessória de cobertura de medicamentos domiciliares, de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS. 5) **Caso dos autos em que o medicamento postulado, "Tofacitinibe 5 mg (Xeljanzt®)", indicado para o tratamento de Alopécia Areata (CID L-63.9) que acomete a autora, é de uso oral e destinado à ministração domiciliar. 6) Considerado que não há no contrato principal previsão acerca da obrigatoriedade de cobertura de medicamentos domiciliares, bem como que não há notícias de contratação acessória, nos termos da RN 310/2012, inexiste qualquer abusividade na negativa de cobertura ofertada pela operadora do plano de saúde.** Alteração de posição em atenção aos recentes julgados da Corte Superior (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021). NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 50087420520218210010, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 28-07-2022) - grifei.*

Nesse mesmo sentido, a recente jurisprudência do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

*1. **Para a jurisprudência do STJ, inexiste abuso na cláusula contratual que desonere os planos de saúde do custeio de medicamentos de uso domiciliar,** salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Precedentes.*

1.1. A Corte de apelação condenou a agravada ao custeio do medicamento de uso domiciliar descrito na inicial, o que afronta a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, não estando o caso concreto inserido nas exceções também previstas na jurisprudência. Por isso, de rigor excluir tal cobertura.

2. Agravo interno que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.107.094/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) - grifos meus.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.

MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESE. INSUMOS. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. TRATAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DO PLANO DE REFERÊNCIA. ART. 10, INCISO VI, DA LEI Nº 9.656/1998. COBERTURA. NÃO OBRIGATORIEDADE.

*1. **É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar,** isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.*

Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021).

2. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde.

3. Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba de infusão de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.042.642/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.) - grifos meus.

Portanto, não vislumbro abusividade na negativa de cobertura feita pela demandada, razão pela qual não prospera o pedido de obrigação de fazer.

Dispositivo

Diante do exposto, **JULGO IMPROCEDENTE** o pedido formulado por **MARIA LEIDIANA MENDES DE OLIVEIRA** em face de **UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento das custas/despesas processuais e ao pagamento de honorários sucumbenciais aos procuradores da parte adversa, os quais, observado o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 12% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade judiciária concedida.

Publicação e registro eletrônicos.

Intimação agendada.

Sobrevindo recurso de apelação, intime-se o recorrido para contrarrazões e, após, independentemente de conclusão, remeta-se o feito ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Com o trânsito em julgado, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **ELIANE APARECIDA RESENDE, Juíza de Direito**, em 26/11/2024, às 17:35:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10071766161v11** e o código CRC **8b959653**.